

FICHA METODOLÓGICA	
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y/O ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL 2025-2029	
1. NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de gestantes, niñas y niños menores de 6 años que acceden a los servicios para la primera infancia.
2. DEFINICIÓN	Relación entre gestantes, niños y niñas menores de 6 años que, según su edad, acceden a servicios para la primera infancia, respecto al total de niños, niñas menores de 6 años y gestantes identificados en las diferentes fuentes administrativas, en un periodo (t) determinado.
3. FÓRMULA DE CÁLCULO	
$PGNSPI_{6 \text{ años}, 4,51 \text{ a } 42 \text{ semanas}}^t = \frac{GNSPI_{6 \text{ años}, 4,51 \text{ a } 42 \text{ semanas}}^t}{TGN_{6 \text{ años}, 4,51 \text{ a } 42 \text{ semanas}}^t} \times 100$	
Donde: $PGNSPI_{6 \text{ años}, 4,51 \text{ a } 42 \text{ semanas}}^t$ = Porcentaje de gestantes, niñas y niños menores de 6 años que reciben los servicios para la primera infancia. $GNSPI_{6 \text{ años}, 4,51 \text{ a } 42 \text{ semanas}}^t$ = Número de gestantes, niñas y niños menores de 6 años que reciben los servicios para la primera infancia, en un momento de tiempo determinado. $TGN_{6 \text{ años}, 4,51 \text{ a } 42 \text{ semanas}}^t$ = Total gestantes, niñas y niños menores de 6 años, identificados en un momento determinado.	
4. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS	
Servicios para la primera infancia: La Ley Orgánica de la Primera Infancia, en su artículo 19, define el paquete integral de servicios como el conjunto de intervenciones que comprenden: servicios de salud integral, servicios de desarrollo infantil integral, servicios de educación y servicios para brindar entornos protectores (Registro Oficial, 2025). Índice del Registro Social: El índice del Registro Social también denominado Puntaje, es el valor numérico que oscila entre cero y cien, como resultado de la aplicación de una metodología de cálculo estadístico de conformidad con las líneas de corte, que permiten identificar las condiciones de pobreza y pobreza extrema de los hogares (Comité Interinstitucional del Registro Social, 2023). Desarrollo Infantil Integral: Es el proceso mediante el cual se fomenta el crecimiento, maduración y desarrollo de las potencialidades y capacidades físicas, cognitivas, comunicativas y socioemocionales de las niñas y niños. Este desarrollo se promueve a través de atenciones que garantizan una buena salud y nutrición, experiencias de juego y aprendizaje, y entornos protectores libres de violencia. Todo ello debe darse en contextos familiares, educativos, sociales y comunitarios que satisfagan sus necesidades afectivo-emocionales y culturales, y que aseguren su libre expresión en contextos diversos (Ministerio de Inclusión Económica y Social [MIES], 2014, 2022).	

Controles del niño sano: Según el “Manual de atención integral a la niñez” del MSP, el control del niño sano, es una estrategia para realizar un seguimiento de la salud al niño, tomando en cuenta la perspectiva del ciclo vital en salud, el cual reconoce los períodos críticos de crecimiento, las fases sensibles del desarrollo, así como los riesgos físicos, sociales, la posibilidad de sufrir enfermedades y el resultado en salud en fases posteriores de la vida (Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP], 2018).

El control de niño sano tiene la finalidad de evaluar de forma cercana el crecimiento y desarrollo, especialmente durante los 2 primeros años de vida, promoviendo un ambiente seguro. La promoción de la salud, la prevención de enfermedades juntamente con el control de crecimiento y desarrollo, han demostrado tener un impacto positivo si se aplican siempre dentro de los controles planificados por grupo etario (MSP, 2018).

Calendarización de controles de niño sano: La metodología para la calendarización de los controles del Niño Sano se fundamenta en el Informe Técnico N.º MSP-GIFDPI-2023-0012, emitido por el Ministerio de Salud Pública (MSP, 2023). En dicho documento se establece la realización de 12 controles de salud, distribuidos por grupo etario (ver Tabla 1), con el propósito de asegurar un seguimiento oportuno, integral y sistemático del crecimiento y desarrollo infantil, especialmente durante los primeros años de vida.

Tabla 1. Calendario de controles del niño sano

Rango de edad	Rango de edad	Número de controles	Número de controles acumulados
De 0 hasta 15 días *	[0 días - 15 días]	1	1
De 16 días hasta 1 mes 29 días	[16 días - 2 meses [	1	2
De 2 a 2 meses 29 días	[2 meses - 3 meses [	1	3
De 3 a 4 meses 29 días	[3 meses - 5 meses [	1	4
De 5 a 5 meses 29 días	[5 meses - 6 meses [	1	5
De 6 a 8 meses 29 días	[6 meses - 9 meses [	1	6
De 9 a 10 meses 29 días	[9 meses - 11 meses [	1	7
De 11 a 12 meses 29 días	[11 meses - 13 meses [	1	8
De 13 a 15 meses 29 días	[13 meses - 16 meses [	1	9
De 16 a 18 meses 29 días	[16 meses - 19 meses [	1	10
De 19 a 21 meses 29 días	[19 meses - 22 meses [	1	11
De 22 a menor a 24 meses	[22 meses - 24 meses [	1	12

*Se toma los registros desde el día 0 para no perder registros.

Nota: Los corchetes abiertos ([) significa que no incluye el rango etario final

Fuente: MSP

Elaboración: STECSDI - DIIE

Control prenatal: Conjunto de actividades y procedimientos que el equipo de salud ofrece a la embarazada con la finalidad de identificar factores de riesgo en la gestante y enfermedades que puedan afectar el curso normal del embarazo y la salud del recién nacido/a (Ministerio

de Salud Pública, 2016). Los componentes que abarca el control prenatal son: promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud materna y neonatal con enfoques de interculturalidad, género y generacional (MSP, 2015).

Calendarización de controles prenatales: La metodología para la calendarización de los controles prenatales es la que consta en el Informe del Ministerio de Salud Pública Nro. MSP-GIFDPI- 2023- 0012, donde se planteó un total de 5 controles de salud distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 2. Calendario de Controles Prenatales

Edad gestacional	Rango de edad gestacional	Número de controles	Número de controles acumulados
Menos de 12 semanas	[0 días – 12 semanas [	1	1
De 12 semanas a 17 semanas y 6 días	[12 semanas – 18 semanas [	1	2
De 18 a 23 semanas y 6 días	[18 semanas – 24 semanas [	1	3
De 24 a 29 semanas y 6 días	[24 semanas – 30 semanas [	1	4
De 30 a 42 semanas	[30 semanas – 42 semanas]	1	5

Nota: Los corchetes abiertos (I) significa que no incluye el rango etario final

Fuente: MSP

Elaboración: STECSDI – DIIE

Bono de desarrollo humano: Mecanismo de aseguramiento no contributivo entregado por el Ministerio de Desarrollo Humano. Con base al artículo 18 del ACUERDO MINISTERIAL No. MIES - 2022 – 037 de 22 de junio de 2022, el bono de desarrollo humano corresponde a una “transferencia mensual de USD 55,00 conceptualizada para cubrir vulnerabilidades relacionadas a la situación económica de los núcleos familiares en situación de pobreza o extrema pobreza conforme Registro Social vigente (...)”. (MIES, 2022)

Bono de desarrollo humano con componente variable: Mecanismo de aseguramiento no contributivo entregado por el Ministerio de Desarrollo Humano. Con base al artículo 19 ACUERDO MINISTERIAL No. MIES - 2022 – 037 de 22 de junio de 2022, el “Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable es una transferencia mensual condicionada que tiene por objeto mejorar los niveles de vida de los núcleos familiares en situación de extrema pobreza conforme el índice de Registro Social vigente y con hijos ecuatorianos menores de 18 años en el núcleo familiar”. (MIES, 2022).

Bono 1000 días: De conformidad con lo establecido en el ACUERDO MINISTERIAL No. MIES - 2022 – 037 de 22 de junio de 2022, el Bono es una transferencia monetaria condicionada de USD 60,00 dirigida a mujeres en gestación y niños y niñas hasta los dos años de vida, que pertenecen a un núcleo familiar en situación de pobreza o extrema pobreza; según información del Registro Social vigente. Este Bono está sujeto al cumplimiento de condicionalidades de corresponsabilidad; y, se entrega de la siguiente manera: USD 50,00 serán entregados de manera mensual como componente incondicional y, USD 10,00 serán entregados de manera acumulada una vez verificado el cumplimiento de las condiciones en cada hito (USD 90 hito 1, USD 120 hitos 2 y 3). (MIES, 2022)

Inscripción de nacimiento: Servicio orientado a inscribir los nacimientos ordinarios o extraordinarios de personas nacidas con atención médica en territorio ecuatoriano. Así como inscribir los nacimientos ordinarios o extraordinarios de personas nacidas con atención médica en el exterior hijos de padre o madre ecuatoriana en oficinas consulares del Ecuador en el exterior (DIGERCIC, 2021).

Matriculación en la modalidad de Educación Formal del Sistema Nacional de Educación: El artículo 38 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece

“Modalidades Educativas. - El Sistema Nacional de Educación comprende la educación formal y no formal, que, planificadas y reguladas por la Autoridad Educativa Nacional, con pertinencia cultural y lingüística; el aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.

1. Educación Formal: Responde a estándares y currículos específicos definidos por la Autoridad Educativa Nacional; es acumulativa, progresiva, conlleva a la obtención de un título y brinda la oportunidad de formación y desarrollo de las y los ciudadanos dentro de los niveles inicial, básico y bachillerato. El Estado garantizará la oferta para todas y todos a lo largo de la vida; (...)”

5. METODOLOGÍA DE CÁLCULO

El indicador se calcula a partir de las siguientes fuentes de información:

Registro administrativo con potencial estadístico

1. Registro de Servicios de Identificación y Cedulación - Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación – DIGERCIC
2. Registro de Nacidos Vivos Registro de Servicios de Identificación y Cedulación - Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación – DIGERCIC
3. Plataforma de Registro de Atenciones de Salud – PRAS - Ministerio de Salud Pública – MSP
4. Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias – RDACAA - Ministerio de Salud Pública – MSP
5. Registro Social - Unidad del Registro Social – URS
6. Registro del Servicio de Desarrollo Infantil Integral – Ministerio Trabajo y Desarrollo Humano– MTDH
7. Registro del Archivo Maestro de Instituciones Educativas – AMIE - Ministerio de Educación, Deporte y Cultura – MINEDEC
8. Registro de beneficiarios de transferencias monetarias no contributivas - Ministerio Trabajo y Desarrollo Humano – MTDH

Dado que estas fuentes de información no están disponibles para el acceso público, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano (MTDH) coordinará con las instituciones que poseen las fuentes de información y realizará el reporte correspondiente.

Numerador:

El numerador del indicador cuantifica los menores de 6 años de quienes se ha verificado la recepción de todos los servicios para la primera infancia que les corresponden de acuerdo a cada una de las siguientes etapas de vida:

- Periodo gestacional
- Primer año de vida
- Segundo año de vida
- Tercer año de vida
- Cuarto año de vida
- Quinto año de vida

En todos los procesos para la definición del numerador se mantiene la unicidad de los registros a nivel de cédula de identidad y por ende se eliminan los duplicados.

Algunos servicios están focalizados para la población en situación de pobreza, por lo que este factor también determina qué servicios se verificarán para cada etapa:

Durante el periodo gestacional para mujeres gestantes:**No identificadas como pobres (puntaje sobre el umbral de pobreza o sin puntaje de Registro Social)**

- Controles de salud (controles prenatales)

Para mujeres gestantes en situación de pobreza (según puntaje de Registro Social)

- Controles de salud (controles prenatales)
- Servicios de Desarrollo Infantil Integral del MTDH (vinculación a CNH)
- Cobertura de transferencias monetarias no contributivas (a la persona o en el núcleo familiar, según corresponda)

Durante el primer y segundo año de vida para niños**No identificados como pobres (puntaje sobre el umbral de pobreza o sin puntaje de Registro Social):**

- Controles de salud (controles del niño sano)
- Inscripción temprana en el Registro Civil (DIGERCIC)

En situación de pobreza (según puntaje de Registro Social)

- Controles de salud (controles del niño sano)
- Servicios de Desarrollo Infantil Integral del MTDH (vinculación a CDI o CNH)
- Inscripción temprana en el Registro Civil (DIGERCIC)
- Cobertura de transferencias monetarias no contributivas (a la persona o en el núcleo familiar, según corresponda)

Durante el tercer año de vida para niños**No identificados como pobres (puntaje sobre el umbral de pobreza o sin puntaje de Registro Social):**

- Inscripción temprana en el Registro Civil (DIGERCIC)

En situación de pobreza (según puntaje de Registro Social)

- Servicios de Desarrollo Infantil Integral del MTDH (vinculación a CDI o CNH) o Servicios de Educación en MINEDEC (matriculación a una institución educativa)
- Inscripción temprana en el Registro Civil (DIGERCIC)
- Cobertura de transferencias monetarias no contributivas (a la persona o en el núcleo familiar, según corresponda)

Durante el cuarto y quinto año de vida para niños

No identificados como pobres (puntaje sobre el umbral de pobreza o sin puntaje de Registro Social):

- Matriculación en la modalidad de Educación Formal del Sistema Nacional de Educación
- Inscripción temprana en el Registro Civil (DIGERCIC)

En situación de pobreza (según puntaje de Registro Social)

- Matriculación en la modalidad de Educación Formal del Sistema Nacional de Educación
- Inscripción temprana en el Registro Civil (DIGERCIC)
- Cobertura de transferencias monetarias no contributivas (a la persona o en el núcleo familiar, según corresponda)

A continuación, se describe la forma de verificación de cada uno de los servicios:

- **Controles de salud (controles prenatales para gestantes y controles del niño sano para menores de dos años)**

Una vez identificada la población gestante mediante las bases de datos de atenciones de salud, se verifica que, para un rango determinado de edad gestacional, la gestante haya recibido el control respectivo a su grupo. Por ejemplo, una gestante con 25 semanas de gestación debe recibir un control en el rango de 24 a 29 semanas. Sin embargo, tiene hasta la semana 29 para realizar este control.

Para considerar que sus controles están al día a la fecha de corte, se verificará que haya recibido una consulta en su rango de edad gestacional actual (24 a 29 semanas) o en el rango inmediatamente anterior (18 a 23 semanas). Si no ha tenido un control en ninguno de estos dos períodos, sus controles no se considerarán al día.

En el caso de niños y niñas, una vez identificada a la población menor de dos años, con base en los registros de PRAS y RDACAA, se identifican los controles de salud (niño sano) más recientes. Se construye una variable que toma el valor de 1 si la niña o niño tiene su control al día, y 0 en caso contrario. Esta evaluación se realiza únicamente para aquellos que hayan recibido al menos una atención en el Ministerio de Salud Pública (MSP), ya que es posible que algunos niños sean atendidos exclusivamente en otras instituciones como el IESS, seguros privados o prestadores particulares. En esos casos, al no contar con registros de estas atenciones externas, no es posible verificar el estado de sus controles, por lo que esta condición no se evalúa.

El control se considera vigente si corresponde a su rango de edad o al inmediatamente anterior, conforme a la calendarización establecida por el Ministerio de Salud Pública.

Para el grupo de 0 a 15 días de edad, se asume automáticamente que está al día, ya que aún no se ha cumplido el tiempo esperado para su primer control.

Por ejemplo, un niño de 7 meses de edad debería haber recibido su sexto control, pero como aún se encuentra dentro del plazo para realizarlo (hasta los 8 meses y 29 días), se considera válido también el quinto control. Es decir, tener el control correspondiente a su edad o el anterior es suficiente para marcar la condición como cumplida.

- **Servicios de Desarrollo Infantil Integral del MTDH (vinculación a CNH para gestantes y CDI o CNH para menores de cuatro años)**

Se determina la condición socioeconómica de la gestante, niña o niño mediante el puntaje del Índice del Registro Social. Se emparejan los datos con los registros de núcleo familiar, priorizando la información de la madre, y en su defecto, la del padre. Para el grupo en situación de pobreza, se realiza un cruce con la base de beneficiarios activos de Servicios de Desarrollo Infantil Integral (SDII) del MTDH, y se construye una variable que indica si recibe dichos servicios. No se considera a las niñas o niños que se encuentran matriculados en el Sistema Nacional de Educación.

- **Matriculación en la modalidad de Educación Formal del Sistema Nacional de Educación**

Una vez identificada la población de niñas y niños de cuatro y cinco años, se verifica su escolarización mediante un cruce con las bases de datos del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (MINEDEC). Este emparejamiento permite determinar si están matriculados en el sistema educativo formal, construyéndose una variable binaria que refleja dicha condición.

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) establece la obligatoriedad de la educación desde el nivel de educación inicial hasta el nivel de bachillerato.

- **Inscripción temprana en el Registro Civil (DIGERCIC)**

Una vez identificada a la población menor de seis años, se verifica si la niña o niño, mediante la base de datos de cedulados, registra una inscripción del nacimiento en el Registro Civil (DIGERCIC) hasta los 45 días de vida, contrastando la fecha de inscripción con la fecha de corte. Se genera una variable binaria que indica cumplimiento cuando la inscripción fue realizada hasta los 45 días de vida a partir de la fecha de nacimiento.

- **Cobertura de transferencias monetarias no contributivas**

Se determina la condición socioeconómica de la gestante, niña o niño mediante el puntaje del Índice del Registro Social. Se emparejan los datos con los registros de núcleo familiar, priorizando la información de la madre, y en su defecto, la del padre. Para el grupo de niños y niñas en situación de pobreza, se verifica si la gestante, niña o niño es beneficiario del Bono 1000 días, o si algún miembro del núcleo familiar recibe el Bono de Desarrollo Humano o el Bono de Desarrollo Humano con componente variable, a través de registros de transferencias monetarias.

Denominador:

El denominador estará conformado por el total de gestantes, niñas y niños menores de seis años identificados en registros administrativos en un periodo de tiempo determinado.

Para determinar la población de menores de seis años identificable, se unen todos los registros de nacimientos de niños, tanto en REVIT Nacimientos como de Cedulados, eliminando los duplicados por número de identidad, en el caso de las niñas y niños que cuenten con número de identidad. A continuación, se realiza el cálculo de la edad en años de cada niño a partir de la diferencia entre la fecha de nacimiento inscrita en la base de datos y la fecha de corte y se verifica que no exista fecha de fallecimiento en sus registros, conservando únicamente las observaciones correspondientes a niños vivos menores de seis años a la fecha de corte. Por otra parte, de los niños identificados tanto en REVIT Nacimientos como en Cedulados que no cuenten con número de identidad, se conservarán aquellos que cuenten con una edad menor a seis años dada su fecha de nacimiento.

La población de mujeres gestantes se determina a partir de las bases de datos del Ministerio de Salud Pública (PRAS y RDACAA). Se genera una base consolidada considerando la fecha de la última menstruación (FUM) más reciente registrada para cada gestante, con el objetivo de calcular la semana de gestación a la fecha de corte.

Posteriormente, esta base se empareja con el Registro Nacional de Cedulados, a fin de excluir los registros de personas que registran fallecimiento. Adicionalmente, se depuran los registros que presentan inconsistencias, tales como: ausencia de FUM, FUM posterior a la fecha de atención médica, o fechas de atención médica posteriores a la fecha de corte.

Posteriormente, se conserva a las gestantes que, a la fecha de corte, presentan una edad gestacional entre 4.51 y 42 semanas, así como a aquellas que, en su última atención médica registrada, alcanzaron al menos 4.51 semanas de gestación. Este umbral se establece debido a que, antes de dicho punto, no existe certeza clínica del embarazo.

Se excluyen del cálculo las gestantes que, antes de la fecha de corte, hayan tenido una atención médica cuyo diagnóstico refleje una interrupción del embarazo o su culminación, conforme a los códigos CIE10: O01–O08 y O60, O72–O75, O80–O91 y O92.1. A continuación, se detalla su alcance:

- O01–O08: Embarazo ectópico, molar, aborto espontáneo o inducido y sus complicaciones.
(Reflejan la interrupción del embarazo, ya sea natural o provocada).
- O60: Parto prematuro espontáneo.
(Indica que la gestación ya concluyó antes de término).
- O72–O75: Complicaciones del parto (hemorragias, retención placentaria, efectos adversos de la anestesia, entre otras).
(Sugieren que el parto ya ocurrió y/o presentó complicaciones).
- O80–O91: Tipos de parto (vaginal, cesárea, múltiple) y complicaciones del puerperio

(sepsis, infecciones, trastornos vasculares, etc.).
(Evidencian que la mujer ya ha dado a luz).

- O92.1: Trastornos del pezón relacionados con el puerperio.
(Asociados a la lactancia; indican etapa posparto).

Estas condiciones médicas implican que el embarazo ya terminó o fue interrumpido, por lo tanto, la mujer no debe ser considerada como gestante activa para fines de cálculo.

Además, se eliminan los registros de mujeres que hayan tenido un parto entre su fecha de última menstruación (FUM) y la fecha de corte. Para ello, se emparejan los nacidos vivos identificados en las bases de datos de nacimientos con sus madres, utilizando su número de cédula, y se verifica si la fecha de nacimiento del hijo/a que se encuentra entre la FUM y la fecha de corte. En dichos casos, se considera que la mujer ya no se encuentra en estado de gestación y, por tanto, se excluye del cálculo.

Después, se filtran los registros para conservar solo aquellos cuya edad gestacional se encuentre entre 4.51 y 42 semanas. La base se ordena en forma descendente por edad gestacional y se eliminan los duplicados por número de cédula. Finalmente, se integran las observaciones provenientes de MSP eliminando nuevamente duplicados y excluyendo a las gestantes sin número de identificación válido.

Resultado:

El indicador se obtiene al dividir el número de gestantes, niñas y niños menores de 6 años que reciben los servicios para la primera infancia que les corresponden de acuerdo a la etapa de vida en la que se encuentran y a su condición de pobreza según el Índice de Registro Social, en un momento de tiempo determinado con respecto al total gestantes, niñas y niños menores de 6 años identificadas en el mismo periodo.

En este sentido, el indicador permite identificar el nivel de cobertura efectiva de los servicios para la primera infancia, desde el periodo gestacional, en función de las etapas de vida y la condición socioeconómica de la población infantil. Evalúa el acceso a intervenciones clave como: controles prenatales, controles de niño sano, inscripción temprana en el registro civil, matriculación en el sistema educativo, participación en servicios de desarrollo infantil integral y recepción de transferencias monetarias no contributivas. Estas intervenciones conforman el paquete básico de servicios orientado a garantizar el bienestar, desarrollo y protección integral de niñas y niños durante sus primeros años de vida.

Nota: La información, tanto para el numerador como para el denominador, se toma con fecha de corte al 31 de agosto de cada año.

6. LIMITACIONES TÉCNICAS

1. Cobertura de fuentes de información: La población de referencia se limita exclusivamente a las niñas y niños identificados en las bases de datos del Registro de Datos Vitales, el Registro de Cedulados y las gestantes registradas en la Plataforma de Registros de Atención en Salud (PRAS) del Ministerio de Salud Pública (MSP) o en el Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA). En

consecuencia, aquellas personas no registradas en estas fuentes no son consideradas en el cálculo del indicador.

2. Calendarización de controles en niñas y niños: Se considera que las niñas y niños menores de 16 días de edad aún están dentro del plazo para cumplir su primer control de niño sano (hasta el día 15 de vida). Por lo tanto, su inclusión como población evaluable puede generar una sobrestimación del cumplimiento en el periodo actual.
3. Calendarización de controles prenatales en gestantes: De forma similar, se asume que las gestantes registradas en un periodo aún tienen la posibilidad de realizarse su control prenatal en el siguiente corte. Esto también puede inducir una sobrestimación temporal del cumplimiento.
4. Actualización de registros: Debido a la naturaleza del registro en línea (PRAS) y fuera de línea (RDACAA), los datos pueden estar sujetos a validaciones y actualizaciones posteriores, lo que implica que los valores del indicador pueden variar después del cierre inicial del periodo analizado.
5. Delimitación de la población en situación de pobreza: El universo de población bajo la línea de pobreza se restringe a los casos identificados a través de registros administrativos disponibles en la Unidad del Registro Social. Por tanto, no se incluyen personas en situación de pobreza que aún no hayan sido captadas o clasificadas formalmente en dicho sistema.
6. El Registro Social es un instrumento estático en el tiempo, por lo que la información únicamente refleja la situación socioeconómica de los hogares en la fecha de levantamiento. El indicador puede experimentar las siguientes variaciones ajenas a la gestión:
 - Cambios metodológicos en el cálculo del Índice del Registro Social
 - Actualización en el tipo de levantamiento del Registro Social a hogares levantados anteriormente
 - Levantamiento de información a nuevos hogares
7. Las fuentes de información no son de acceso público, por lo que el MTDH remite la actualización de la información mediante informes técnicos.

7. UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR	Porcentaje (%)
8. INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	En el mes xxx del año 20XX, el XX,XX% de gestantes, niñas y niños menores de 6 años acceden a los servicios para la primera infancia.
9. FUENTE DE DATOS	Registro administrativo con potencial estadístico • Registro de Servicios de Identificación y Cedulación - Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación – DIGERCIC • Registro de Nacidos Vivos Registro de Servicios de Identificación y Cedulación - Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación – DIGERCIC

		• Plataforma de Registro de Atenciones de Salud – PRAS - Ministerio de Salud Pública – MSP • Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias – RDACAA - Ministerio de Salud Pública – MSP • Registro Social - Unidad del Registro Social – URS • Registro del Servicio de Desarrollo Infantil Integral - Ministerio Trabajo y Desarrollo Humano – MTDH • Registro del Archivo Maestro de Instituciones Educativas – AMIE - Ministerio de Educación, Deporte y cultura – MINEDEC • Registro de beneficiarios de transferencias monetarias no contributivas - Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano – MTDH
10. PERIODICIDAD DEL INDICADOR		Anual
11. DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS		Desde el año 2023
12. INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE LA TRANSFERENCIA DEL INDICADOR E INSUMOS		Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano
13. FECHAS DE TRANSFERENCIA DEL INDICADOR E INSUMOS		Hasta el 27 de febrero del año en curso se reportará información del año anterior.
14. NIVEL DE DESAGREGACIÓN	GEOGRÁFICO	Nacional
	GENERAL	No aplica
	OTROS ÁMBITOS	No aplica
15. INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA		No aplica
16. RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL		Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025 Eje: Social Objetivo: Mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, garantizando el goce efectivo de los derechos y la reducción de las desigualdades.
		Comité Interinstitucional del Registro Social. (2023, 23 de noviembre). Resolución normativa Nro. CIRS-RN-001-2023: Reforma a la Norma Técnica para la aplicación e implementación del modelo de actualización permanente de la base de datos e información del Registro Social de 23 de febrero de 2022 (Registro Oficial N.º 443). Quito, Ecuador.

**17. BIBLIOGRÁFICAS
DE LA CONSTRUCCIÓN
DEL INDICADOR**

**REFERENCIAS
DE LA
DEL**

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, (2021). Inscripción de nacimiento.

Ministerio de Salud Pública de Ecuador. (2023). Informe técnico calendarización de controles (0-6 meses) del niño sano. MSP.

Comité Interinstitucional del Registro Social. (2025). <https://www.registrosocial.gob.ec/se-lleva-a-cabo-la-sesion-ordinaria-del-comite-interinstitucional-del-registro-social-2025/>

Ministerio de Desarrollo Humano, (2022). Acuerdo ministerial Nro. MIES-2022-051. Norma Técnica del Servicio de Centros de Desarrollo Infantil CDI.

Ministerio de Desarrollo Humano, (2021). Transferencias monetarias no contributivas. Obtenido de: <https://info.desarrollohumano.gob.ec/>

Ministerio de Inclusión Económica y Social, (2014). Desarrollo Infantil Integral. Obtenido de: <https://info.desarrollohumano.gob.ec/>

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2018). Atención integral a la niñez: Manual (3.ª ed.). Quito, Ecuador. Recuperado de

Ministerio de Salud Pública (2015). Control Prenatal: Guía de Práctica Clínica (GPC). Ministerio de Salud Pública, Dirección Nacional de Normatización, Quito. Obtenido de <https://www.salud.gob.ec/>

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2021). Obtenido de: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Ley_Organica_de_Educacion_Intercultural_LOEI_codificado.pdf

Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil (2022). Metodología para la identificación, evaluación, continuidad y cumplimiento de condicionalidades de la población beneficiaria del “Bono 1000 Días”.

Presidencia de la República del Ecuador. (2022). Decreto Ejecutivo No. 435, de 1 de junio de 2022. Registro Oficial No. 435, 1 de junio de 2022

	Ministerio de Desarrollo Humano, (2022). Acuerdo Ministerial no. Mies - 2022 – 037. Obtenido de: https://www.desarrollohumano.gob.ec/wp-content/uploads/2022/06/037_-acuerdo_REGULAR-EL-PAGO-DE-TRANSFERENCIAS-MONETARIAS-DEL-SISTEMA-DE-PROTECCION-SOCIAL-INTEGRAL-signed-1.pdf
18. FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA	30 de julio 2025
19. FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA	a) Versión 1: 30 de julio de 2025 b) Versión 2: 01 de abril de 2026 c) Última versión: 25 de septiembre de 2026
20. CLASIFICADOR TEMÁTICO ESTADÍSTICO	1. Estadísticas Sociales y Demográficas ¹
21. HOMOLOGACIÓN DEL INDICADOR	Homologado por el Comité Especial de Información
22. FECHA DE HOMOLOGACIÓN DEL INDICADOR	Mediante sesión extraordinaria 016-CEI-SE-2025 del 30 de julio de 2025, el Comité Especial de Información homologó la metodología de cálculo del indicador para el PND 2025-2029
23. RESEÑA DEL INDICADOR	El indicador se basa en la metodología de cálculo del indicador “Porcentaje de niñas y niños menores de 6 años y gestantes con sus servicios integrales al día”, aprobado por el MSP, MIES y STECSDI”. Indicador propuesto por el Ministerio de Inclusión Económica y Social para ser incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029 mediante Oficio Nro. MIES- MIES-2025-0898-O de fecha 22 de julio de 2025. En atención al Memorando Nro. PR-SSDP-2026-0012-M, de 24 de febrero de 2026, y en el marco de la aplicación de la Norma Técnica para actualizaciones de líneas base, modificaciones menores y metas del Plan Nacional de Desarrollo, se procedió a la actualización de la ficha metodológica del indicador como parte del proceso de modificación menor por cambio de responsable de meta, derivado de los Decretos Ejecutivos relacionados con la fusión por absorción de entidades de la Función Ejecutiva. En atención al Memorando Nro. PR-SSDP-2026-0077-M, de 20 de agosto de 2026, y en el marco de la aplicación de la Norma Técnica para actualizaciones de líneas base, modificaciones menores y metas del Plan Nacional de Desarrollo, se procedió a la actualización de la ficha metodológica del indicador como parte del proceso de modificación menor por cambio de responsable de meta, derivado de los Decretos Ejecutivos

¹ Considerando el alcance del indicador, que abarca temáticas como población, educación, salud y protección social

	relacionados con la fusión por absorción de entidades de la Función Ejecutiva.
24. ELABORADO POR	- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano - Subsecretaría de Gestión de Datos y Estudios - Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República del Ecuador - Secretaría General de la Administración Pública y de Gabinete

25. SINTAXIS DEL INDICADOR

No aplica

26. SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR

Año	Indicador	Numerador	Denominador
2023	38,19%	655.308	1.715.742
2024	38,91%	638.616	1.641.107
2025	39,83%	622.998	1.564.051

Formato: Versión 7.

Delegaciones Institucionales Responsables de la Homologación del Indicador

Delegación	Firmas de responsabilidad
William Adrián Villavicencio Cevallos PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: WILLIAM ADRIAN VILLAVICENCIO CEVALLOS
Lorena Álvarez Figueroa INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS	 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: LORENA MARIA ALVAREZ FIGUEROA
Karina Elizabeth Guamaní Clavijo MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: KARINA ELIZABETH GUAMANI CLAVIJO